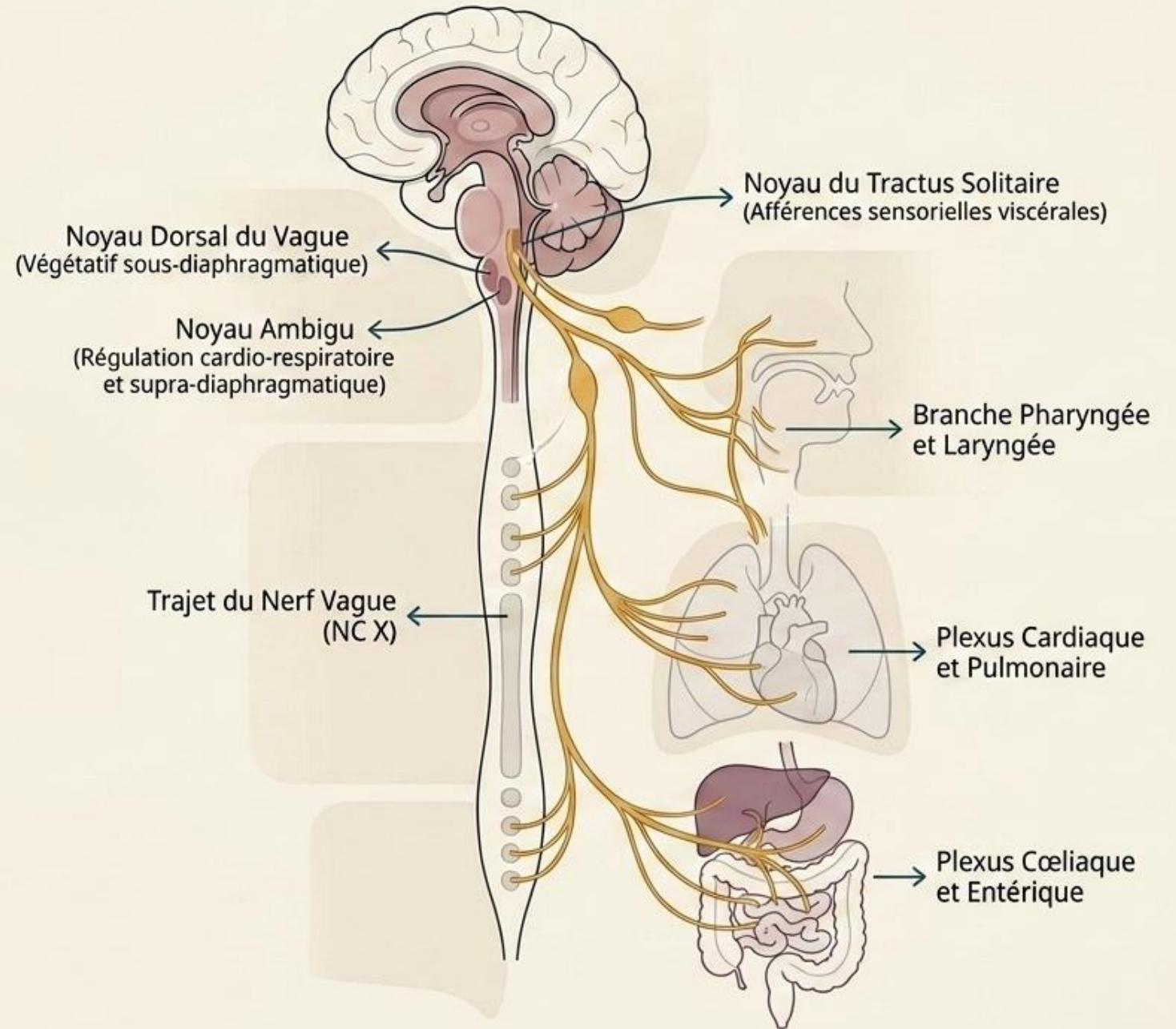


Théorie Polyvagale et ROP

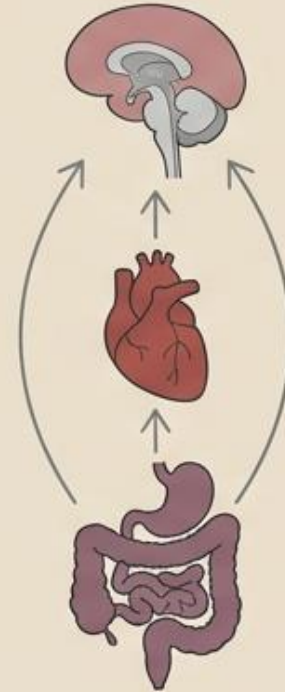


Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)



Historiquement, la réponse au stress était vue comme une activation prioritaire et exclusive du système sympathique.

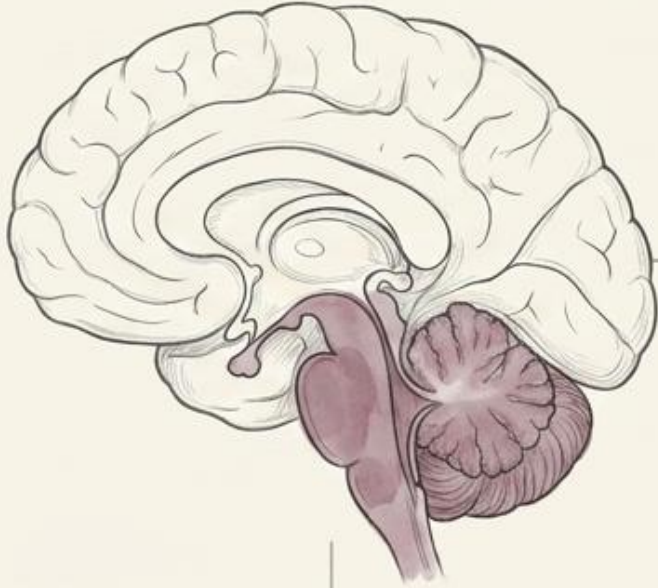
La Théorie Polyvagale (Stephen Porges)



Met en évidence le rôle différencié de deux voies vagales distinctes.

80% des afférences viscérales transmises au cerveau proviennent du nerf vague.
L'état corporel dicte l'état mental et émotionnel.

La Chronologie Évolutive du Système Autonome



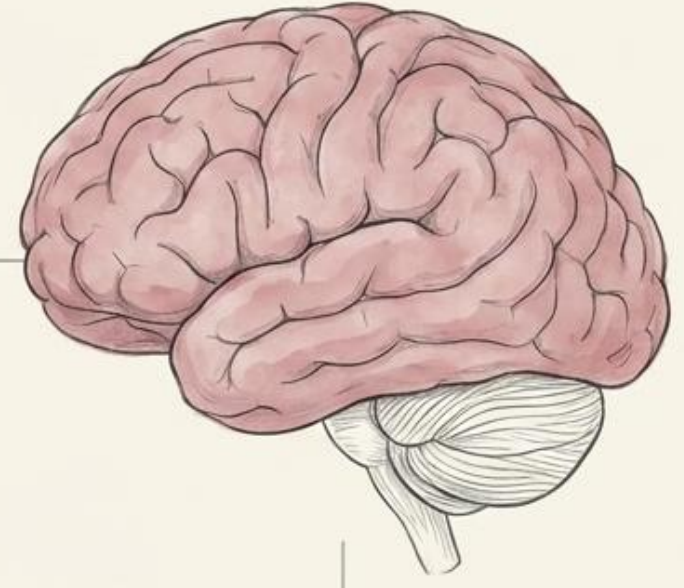
Phase 1 (Reptilien) : Branche Ancienne du Nerf Vague

Immobilisation, figement, bradycardie.
La réponse de dernier recours quand la fuite est impossible.



Phase 2 (Mammifère Ancien) : Système Sympathique

Mobilisation, fuite ou combat.
Apparu pour l'exploration et la défense active.

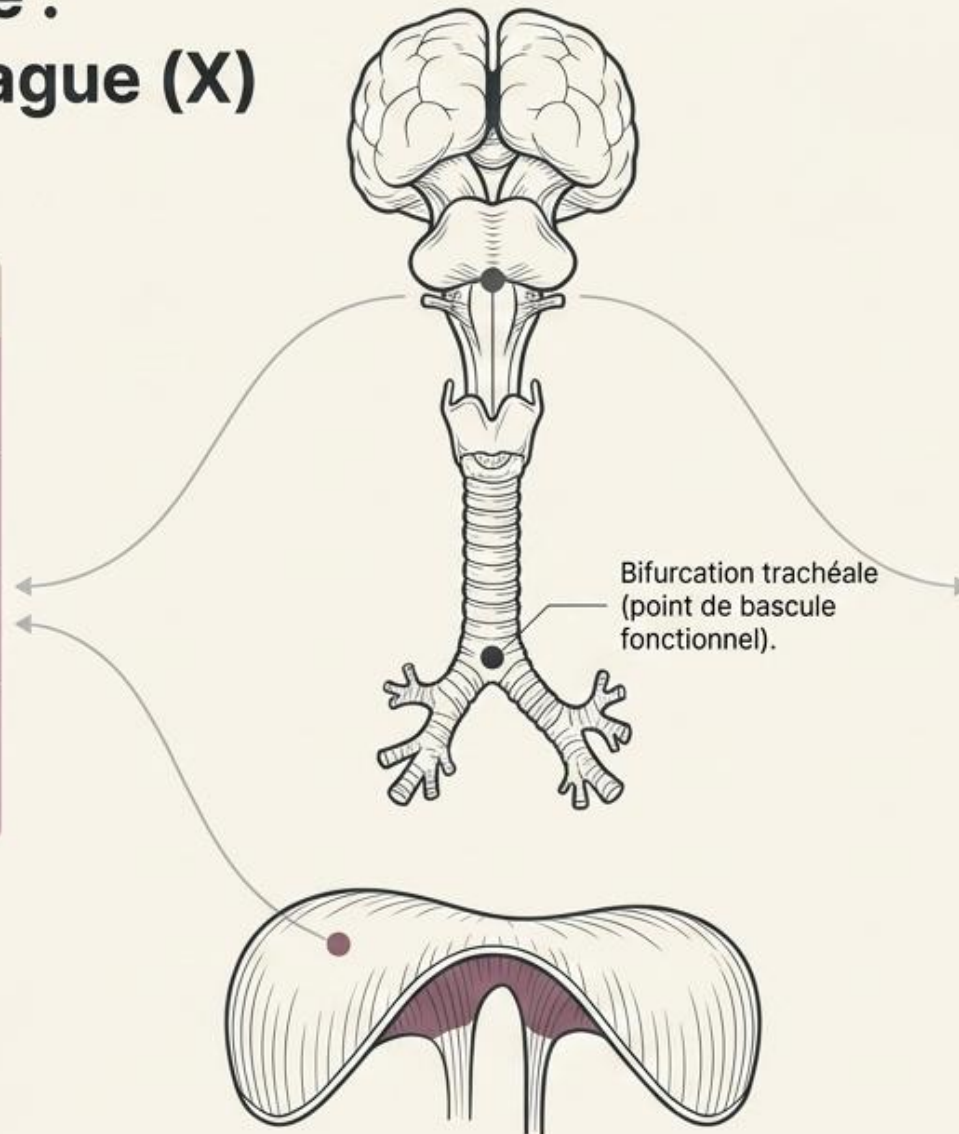


Phase 3 (Humain/Mammifère Supérieur) : Branche Nouvelle du Nerf Vague

Engagement social, sécurité, apaisement.
Liée au cerveau cognitif et à l'attachement affectif.

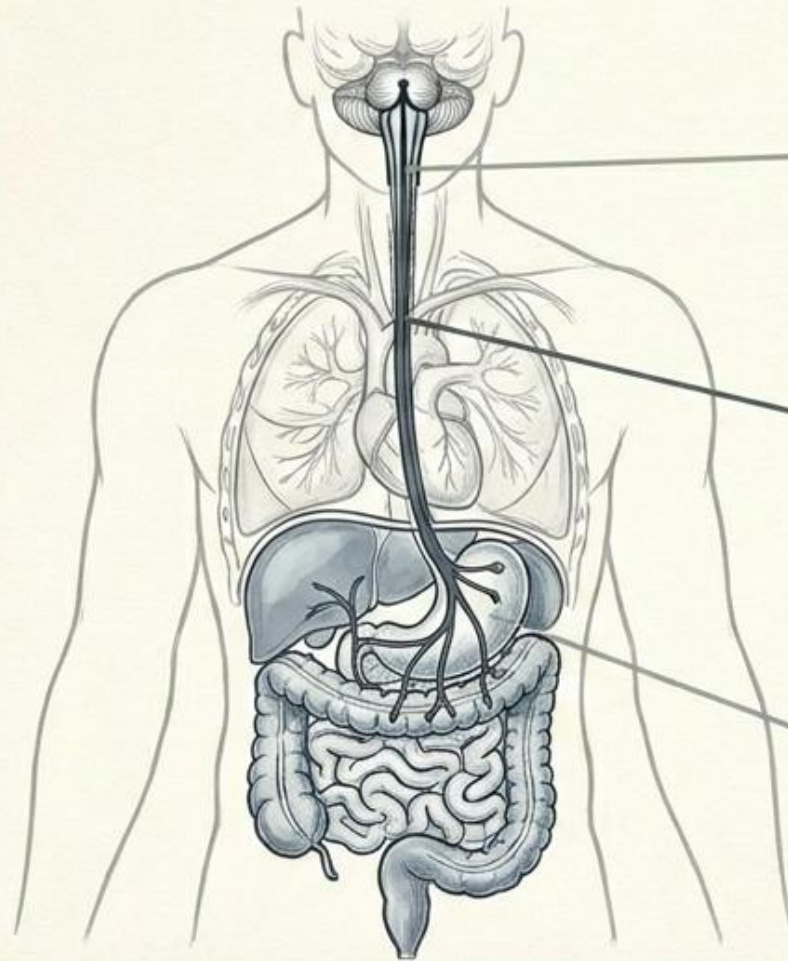
Matrice Différentielle : La Dualité du Nerf Vague (X)

Branche Ancienne / Dorsale
Origine : Noyau dorsal de la moelle allongée.
Structure : Fibres non myélinisées (conduction lente).
Destinée : Viscères infra-diaphragmatiques.
Fonction : Fonctions végétatives (digestives, génitales) et survie archaïque (figement).



Branche Nouvelle / Ventrale
Origine : Noyau ambigu de la moelle allongée.
Structure : Fibres myélinisées (conduction rapide et modulée).
Destinée : Organes sus-diaphragmatiques (rythme cardiaque).
Fonction : Engagement social, variabilité du rythme cardiaque (VRC), équilibre émotionnel.

Phase 1 : Le Nerf Vague Ancien (Branche Dorsale)



Origine : Noyau dorsal de la moelle allongée (Tronc cérébral). Fibres non myélinisées (conduction lente).

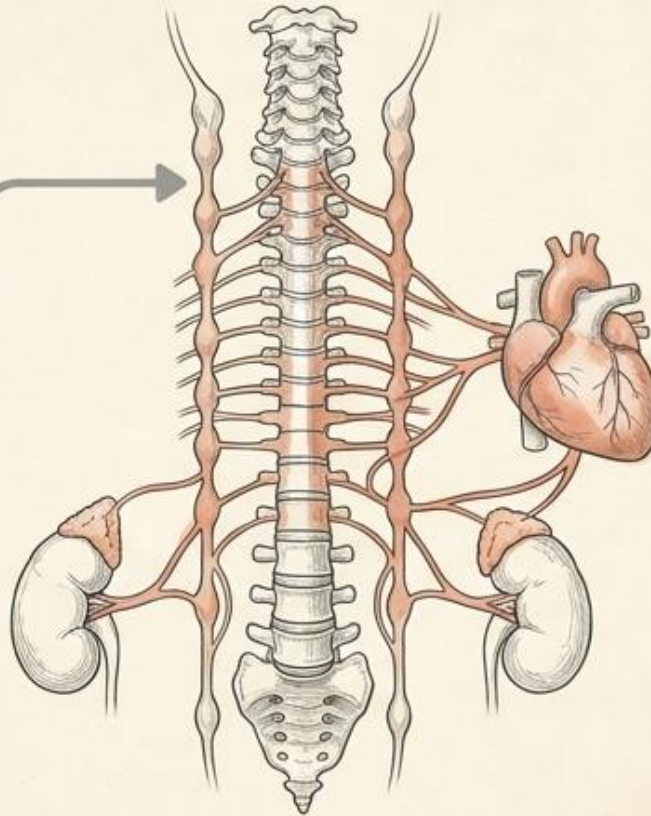
Non-myélinisé

Destinée : Viscères infra-diaphragmatiques (digestifs, génitaux, urinaires).

Mode de réponse : Se figer, s'évanouir, bradycardie.
Activé quand la fuite ou le combat sont impossibles.

Phase 2 : Le Système Sympathique

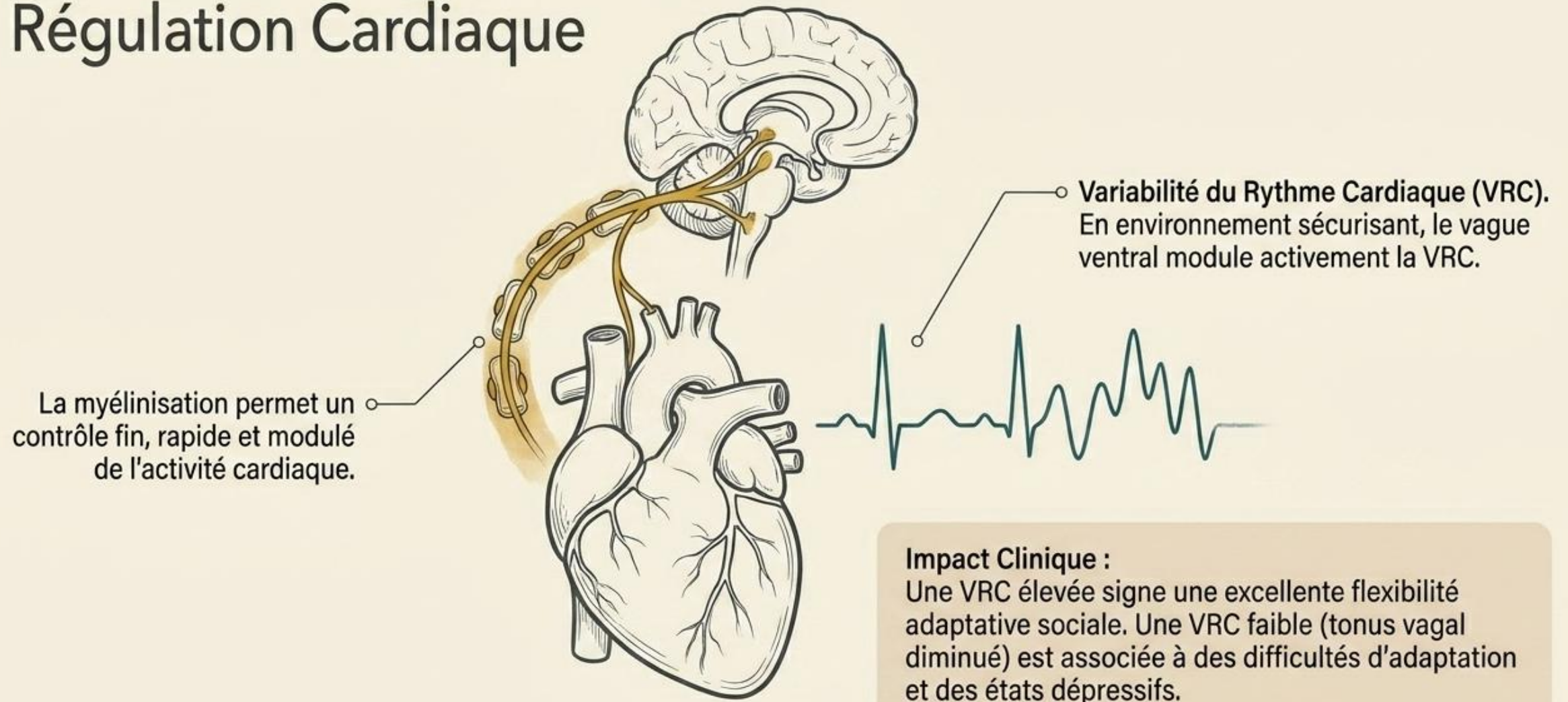
Développement
parallèle au système
limbique.
Émergence au niveau
de la moelle épinière.



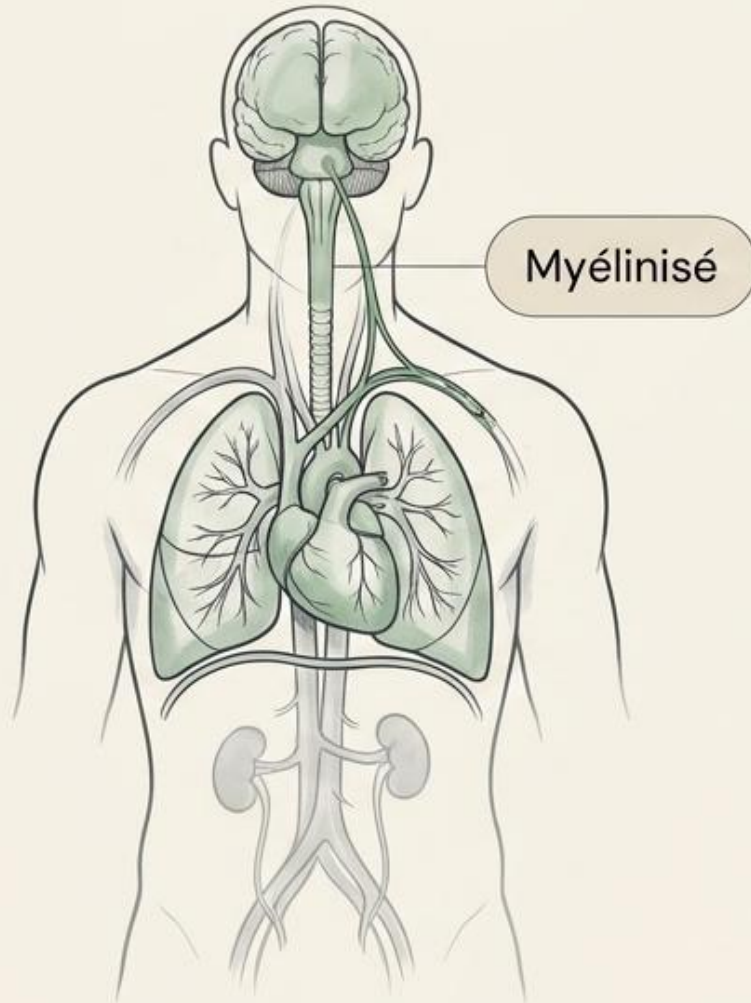
Destinée :
Action musculaire,
accélération
cardiaque,
mobilisation globale.

Mode de **réponse** : Fuir ou combattre face à un
environnement hostile.

Neurophysiologie de la Régulation Cardiaque



Phase 3 : Le Nerf Vague Nouveau (Branche Ventrale)



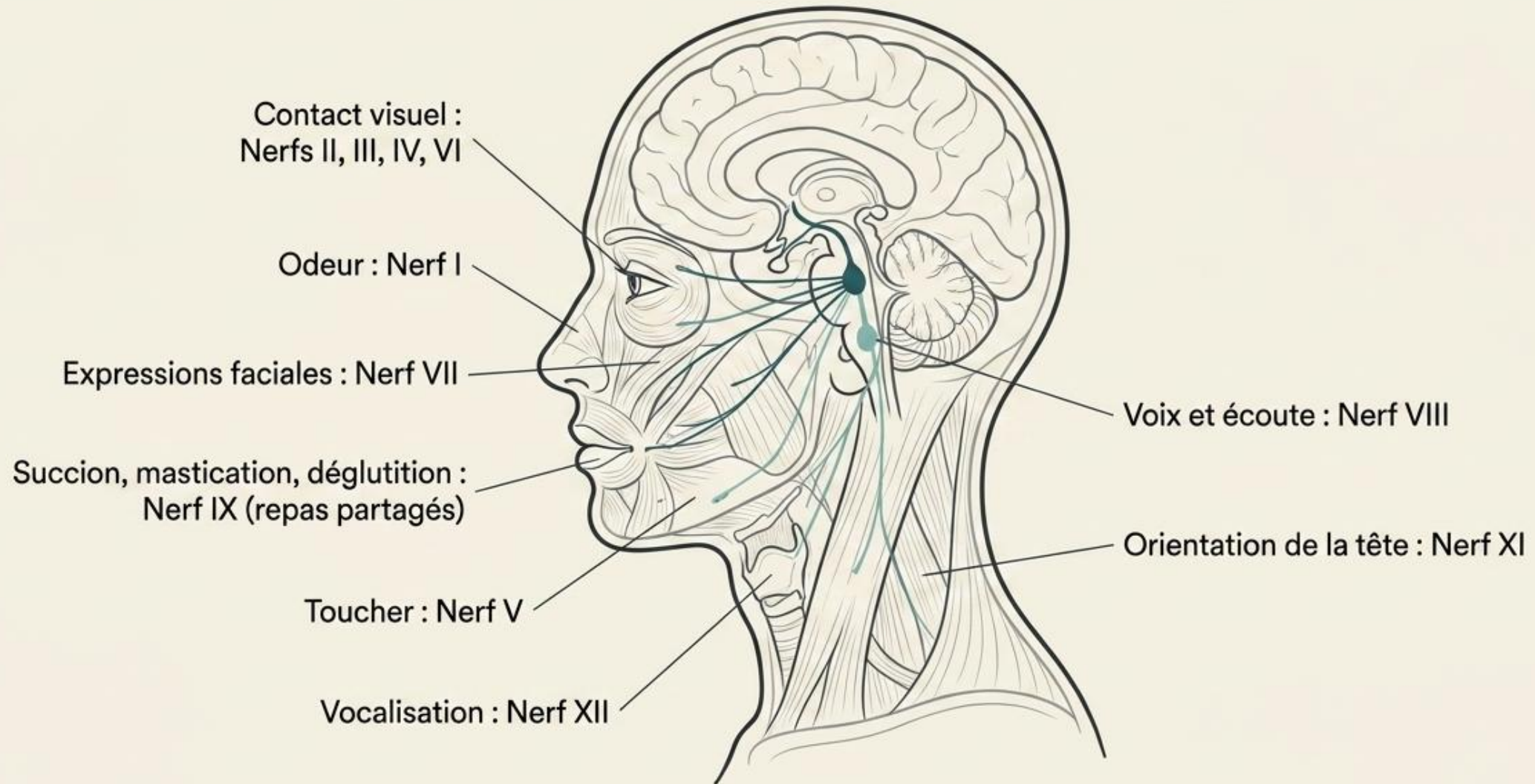
Origine : Noyau ambigu de la moelle allongée.
Fibres myélinisées (conduction rapide et modulée).
Destinée : Organes sus-diaphragmatiques (cœur, poumons).

Régule le rythme cardiaque et la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VRC). Une VRC élevée offre flexibilité et adaptation au stress.

Mode de réponse : Engagement social, apaisement, sentiment de sécurité.

La neurophysiologie de l'engagement social

La branche ventrale opère en réseau avec d'autres noyaux moteurs crâniens pour fonder physiologiquement nos interactions.





L'Odeur : Nerf olfactif (I)

Le Contact Visuel : Nerfs optique (II)
et oculomoteurs (III, IV, VI)

Le Regard (orientation) : Nerf accessoire (XI)

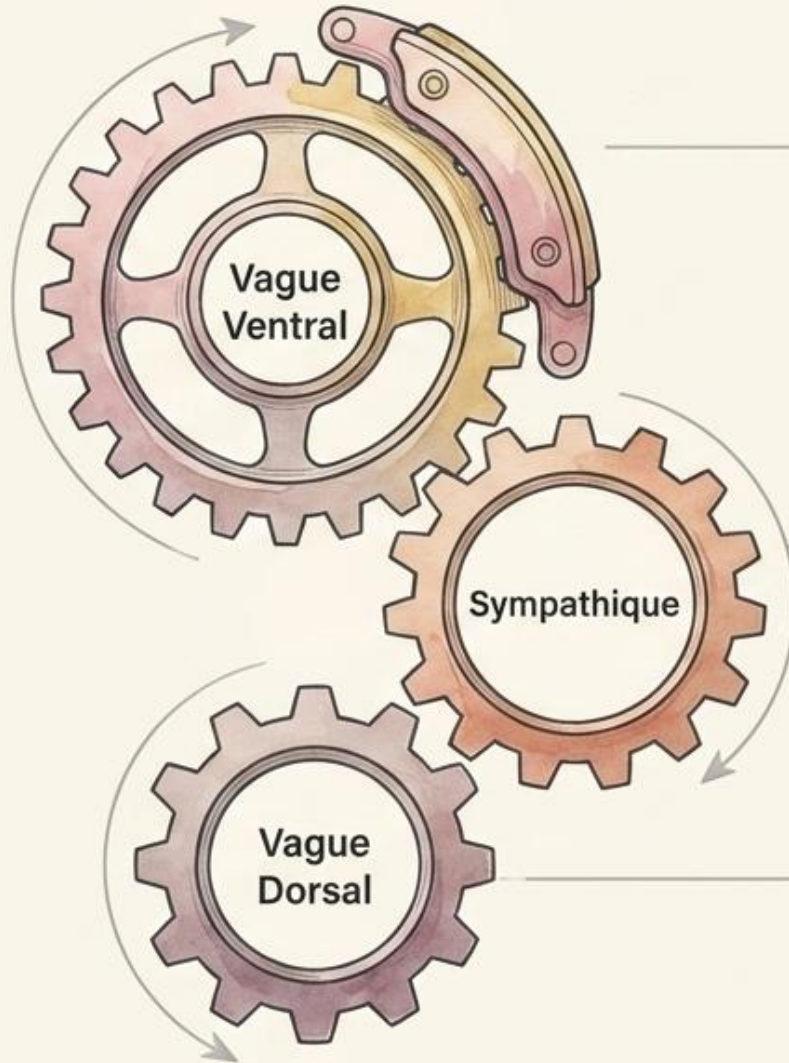
L'Expression Faciale : Nerf facial (VII)

La Voix : Nerf vestibulaire-cochléaire (VIII)

Le Toucher & La Succion : Nerf trijumeau (V),
glosso-pharyngien (IX), hypoglosse (XII) - Permet
la tétée, la mastication et la vocalisation.

À la naissance, la survie dépend de ces afférences.
Dans des conditions optimales, ce complexe crânien
(Branche Ventrale) exerce un contrôle hiérarchisé sur
l'ensemble du système autonome.

La Neuroception et le Frein Vagal



Le Contrôle Supérieur

Dans un environnement sûr, la branche ventrale maintient un frein actif sur le système sympathique.

La Libération Sympathique

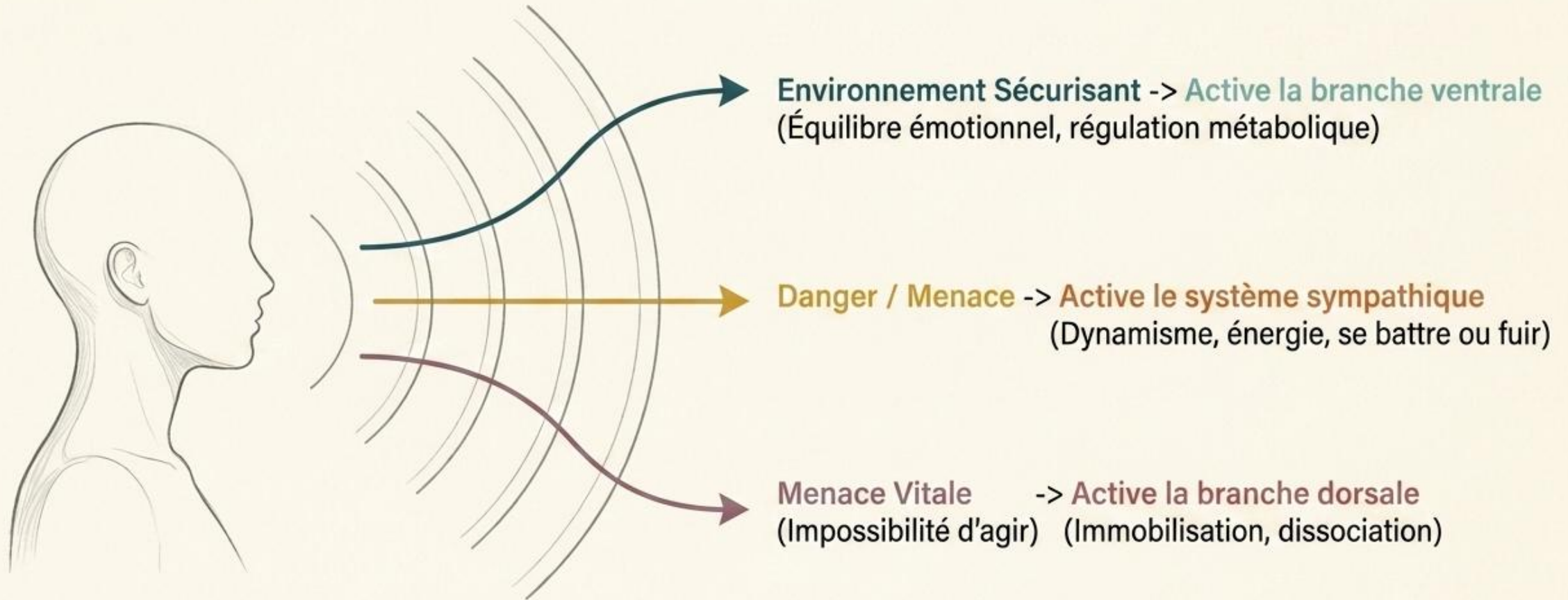
C'est essentiellement l'abaissement du tonus vagal ventral (face à une menace) qui libère l'activité sympathique, et non une augmentation indépendante de ce dernier.

L'Effondrement

Si le sympathique est submergé, le vague ancien (dorsal) prend le relais, provoquant figeage ou syncope (malaise vagal).

Neuroception : La détection subconsciente

La capacité du système nerveux à sonder l'environnement sans conscience volontaire

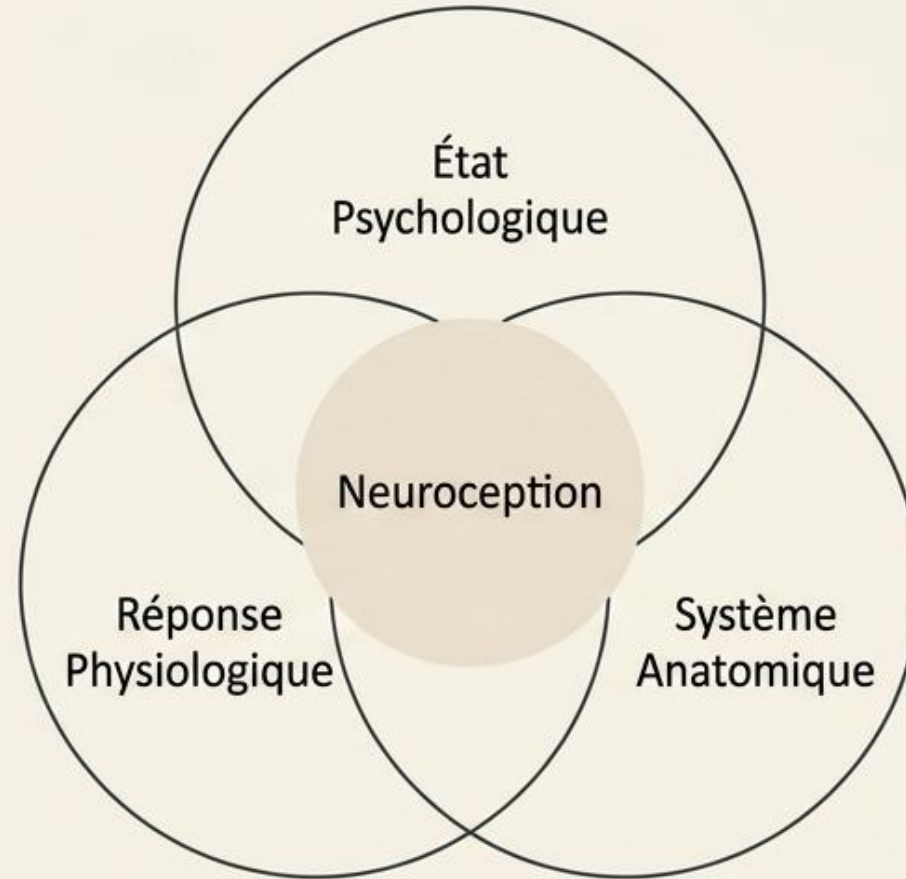


Dès l'enfance, les traumatismes physiques ou psychiques peuvent biaiser la neuroception et orienter le système dominant.

Synthèse : La Neuroception et le Contrôle Interne

La « Neuroception » est la capacité inconsciente du système nerveux à sonder son environnement (intérieur et extérieur) pour évaluer la sécurité ou le danger.

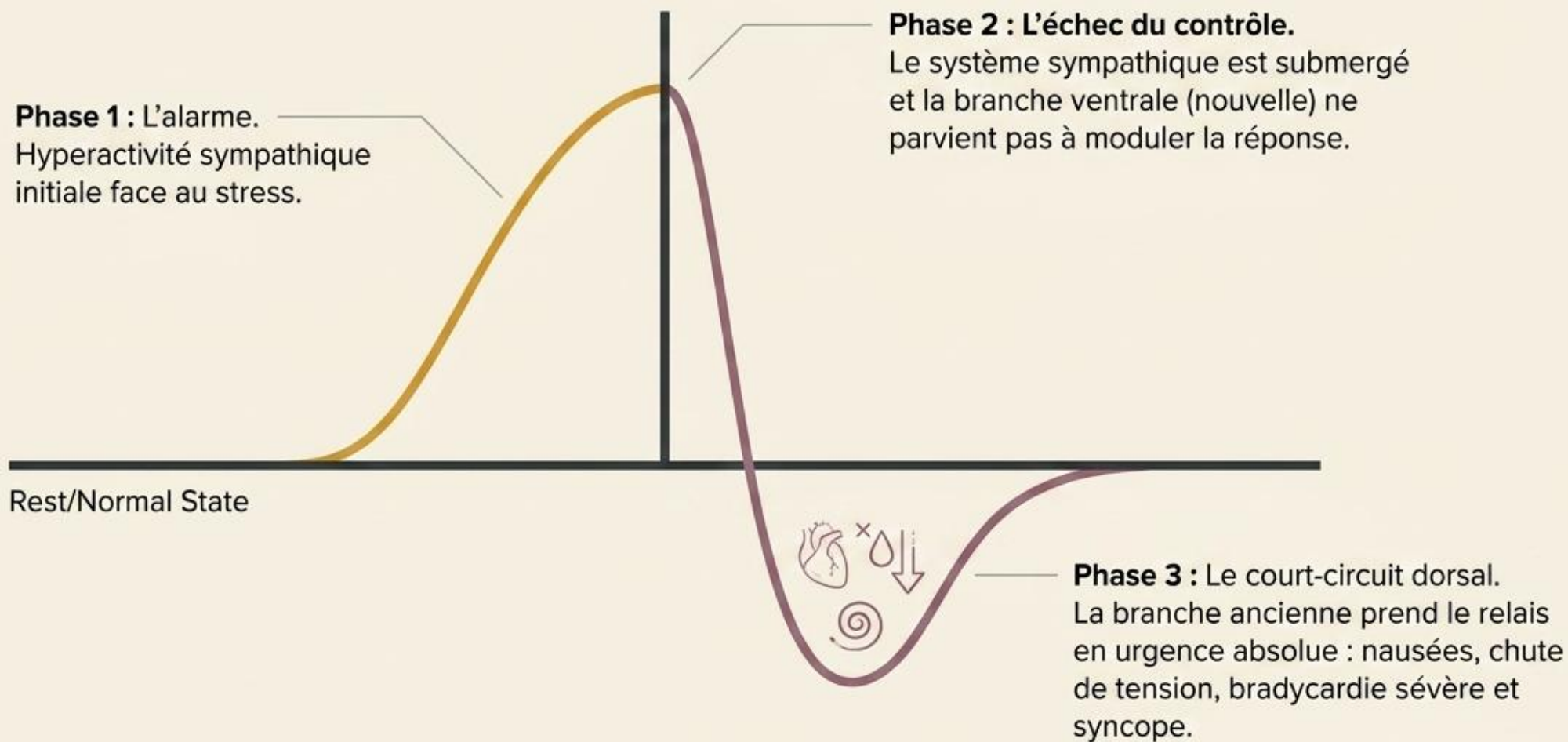
Le Levier Clinique : Les traumatismes physiques, psychiques ou émotionnels précoces orientent le système dominant.



L'Insight ROP : Le stress sympathique n'est pas une attaque autonome. C'est le résultat d'un lâcher-prise du frein vagal ventral supérieur. L'intervention ne doit pas seulement calmer le sympathique, elle doit réengager le vague ventral en restaurant un état tissulaire de sécurité.

Le paradoxe vagal et l'effondrement physiologique

Le malaise vagal s'explique par une défaillance du contrôle hiérarchique.



Le Paradoxe Vagal

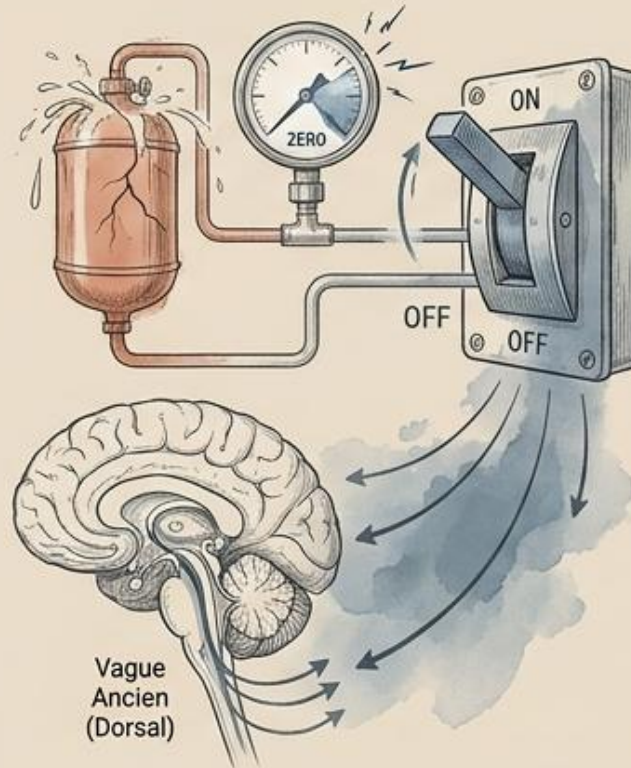


La contradiction parasympathique

Comment un système conçu pour apaiser peut-il provoquer nausées, colites, fatigue extrême ou syncope (Malaise vagal) ?

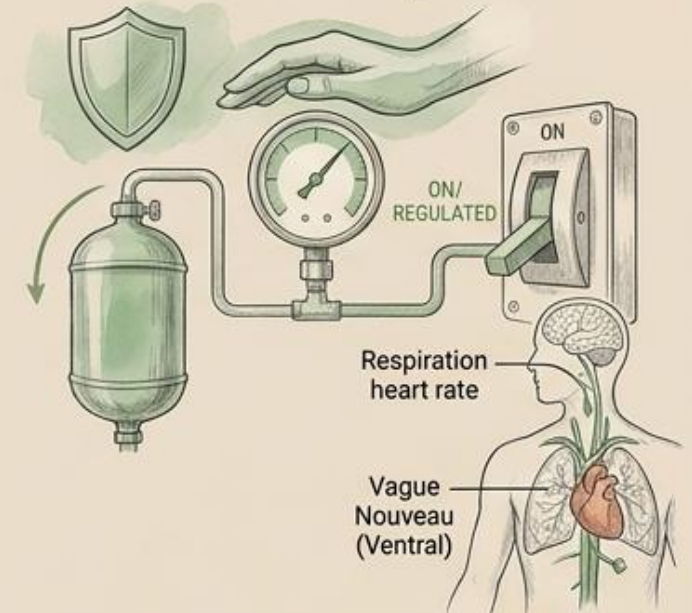
Le mécanisme de suractivation

C'est la suractivation de la branche ANCIENNE du nerf vague (réponse reptilienne de survie extrême) face à une menace perçue comme inéluctable.



La résolution régulatrice

La théorie polyvagale démontre que seule la branche NOUVELLE (ventrale) est capable de réguler à la fois l'hyperactivité sympathique et la suractivation du vague ancien.



La théorie polyvagale démontre que seule la branche NOUVELLE (ventrale) est capable de réguler à la fois l'hyperactivité sympathique et la suractivation du vague ancien.

CONSÉQUENCES CLINIQUES DU STRESS PROLONGÉ



Sphère Viscérale

- Troubles digestifs
- Perméabilité intestinale
- Dysbioses
- Foie congestionné
- Douleurs viscérales
- Fatigue profonde



Sphère Hormonale

- Déséquilibre Cortisol/DHEA
- Fatigue surrénalienne
- Troubles métaboliques
- Troubles du sommeil
- Déséquilibres thyroïdiens

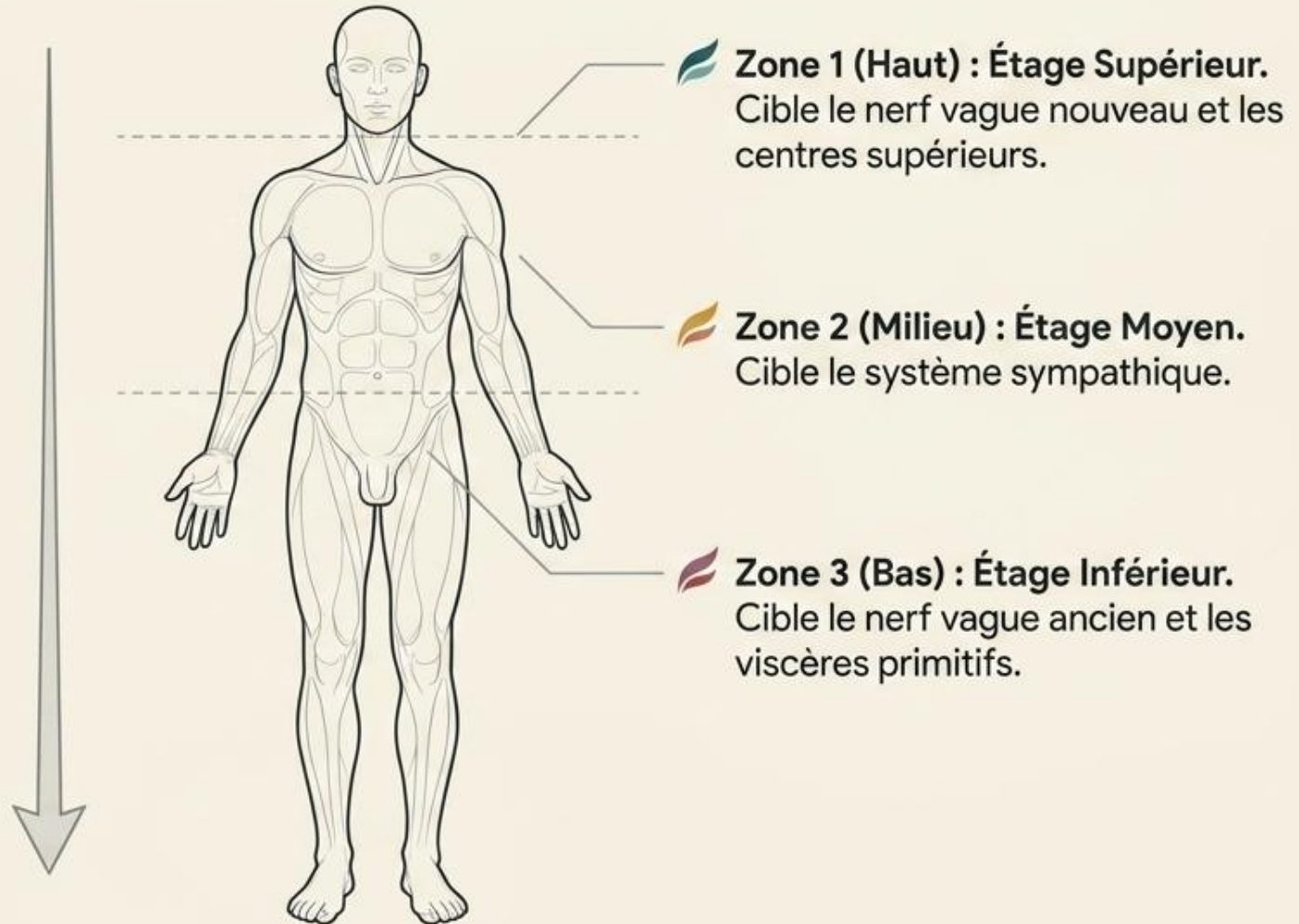


Sphère Somatique

- Tensions musculaires
- Douleurs chroniques
- Céphalées
- Troubles posturaux
- Épuisement physique

L'impératif thérapeutique ROP : Une approche hiérarchisée

Parce que le Système Nerveux Autonome fonctionne selon une hiérarchie descendante, l'approche clinique (anamnèse, examen, traitement) doit impérativement s'organiser de haut en bas.



Protocole ROP : L'Étage Supérieur (Vague Nouveau)

Objectif : Réactiver le contrôle hiérarchique supérieur et les connexions avec le SNC.

Charnière crânio-cervicale
(Occiput-C1-C2) et Foramen magnum

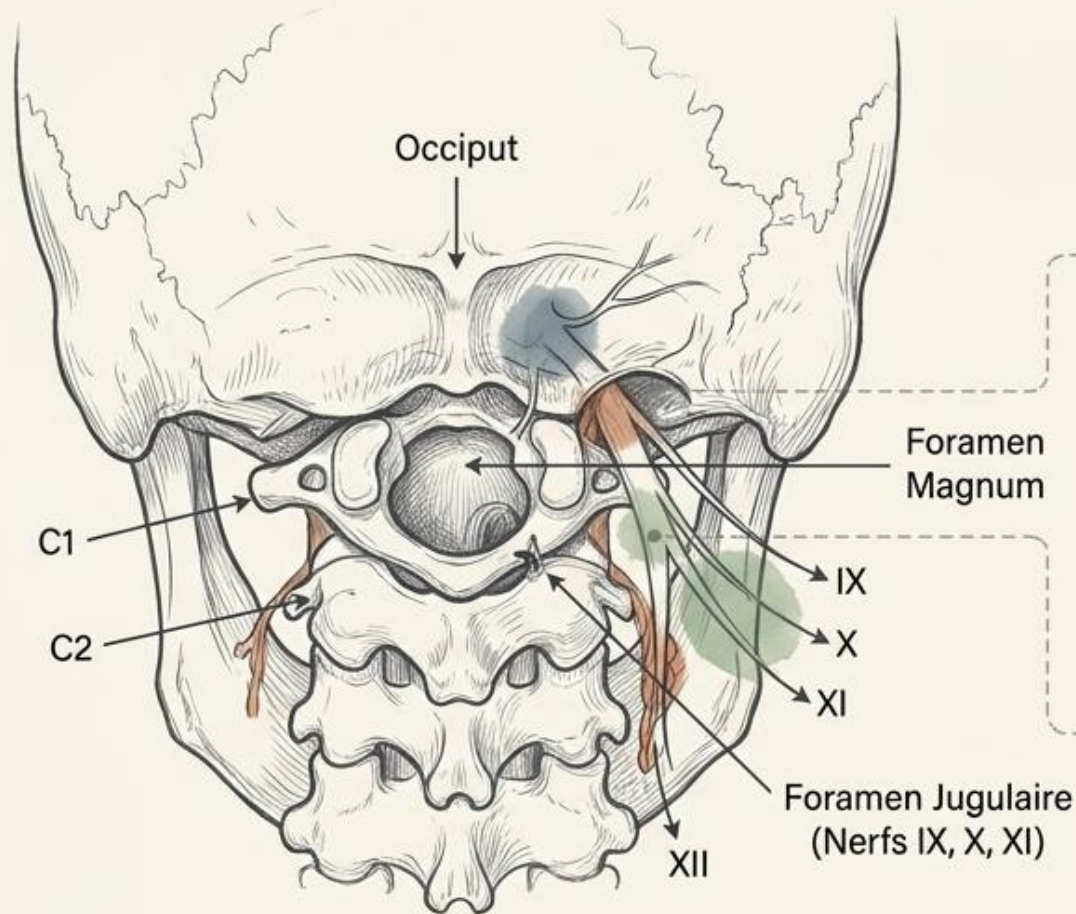
Rééquilibration de la Symphyse
Sphéno-Basilaire (SSB) jusqu'à S2

Dure-mère crânienne (faux du cerveau,
tente du cervelet) & compression du 4ème
ventricule (CV4)



Foramen jugulaire
(nerfs IX, X, XI) et canal
de l'hypoglosse (XII)

Viscères supra-
diaphragmatiques
diaphragmatiques
(plexus cardiaque)



Structures Cibles :

- Charnière crânio-cervicale (Occiput-C1-C2) et Foramen magnum.
- Foramen jugulaire (passage des nerfs IX, X, XI).
- Nerf Trijumeau (V) et Hypoglosse (XII).

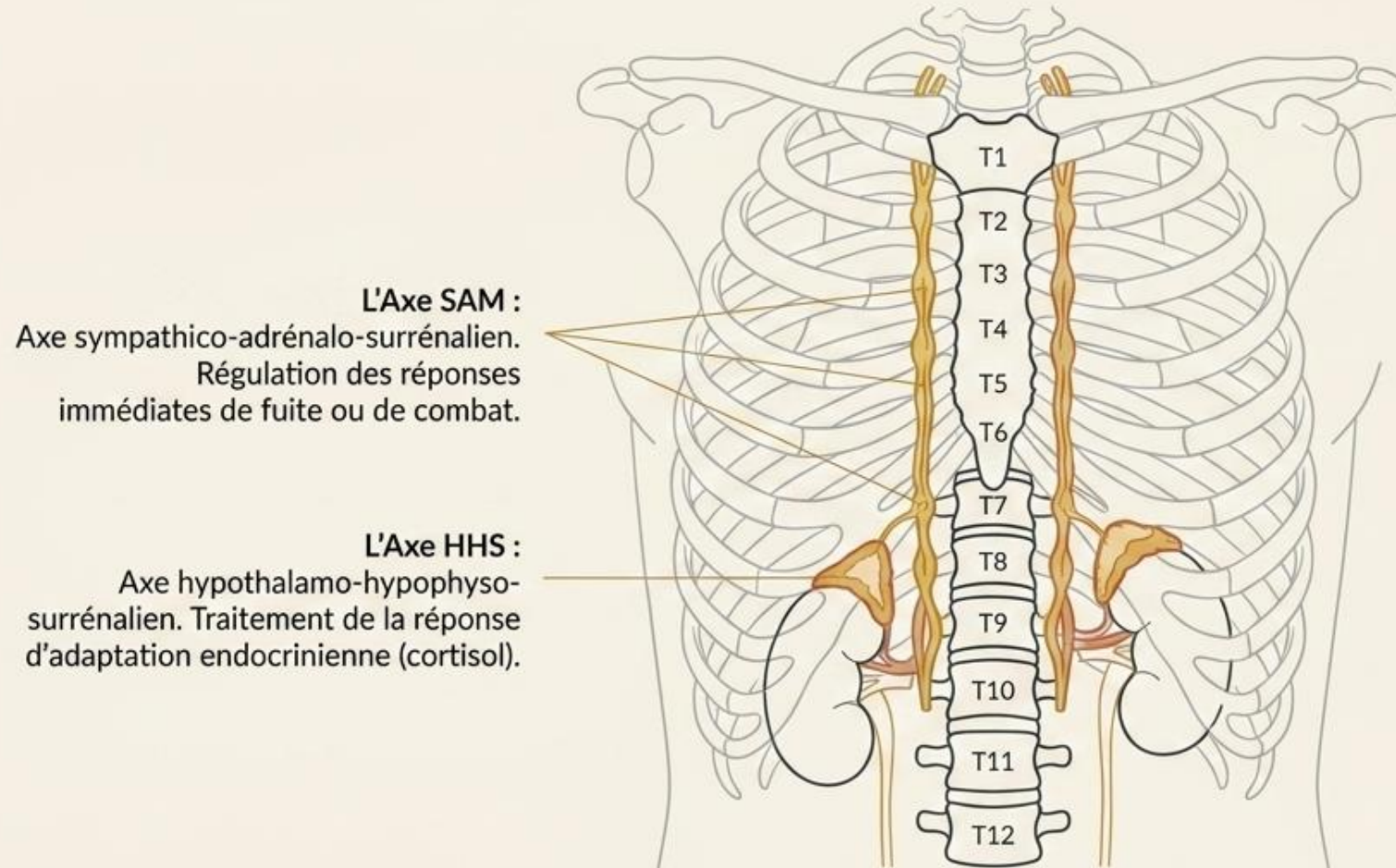
Techniques Clés :

- Rééquilibration Symphyse Sphéno-Basilaire (SSB) - S2.
- Compression du 4^{ème} ventricule.

Objectif Thérapeutique : Stimuler le nerf vague nouveau pour instaurer la « neuroception de sécurité » et réguler l'ensemble de la cascade autonome.

Protocole ROP II : L'étage moyen

Modulation du système sympathique et de la mobilisation



Intervenir sur cet étage permet de désamorcer l'hyperactivité sympathique avant qu'elle ne submerge les viscères de l'étage inférieur.

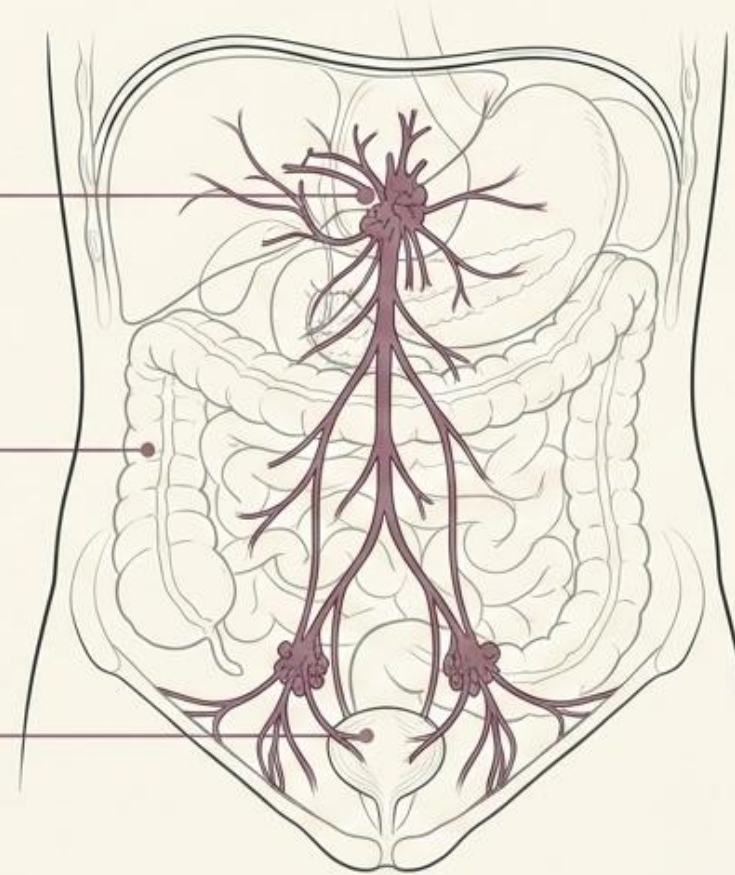
Protocole ROP III : L'étage inférieur

Sécurisation de la branche ancienne et des viscères profonds.

Le Plexus Cœliaque :
Carrefour neuro-végétatif majeur
de l'abdomen.

Viscères sous-diaphragmatiques :
Relâchement des tensions liées à
l'immobilisation de survie (sphère
digestive).

Le Plexus Hypogastrique :
Régulation des fonctions
génito-urinaires de base.



Ne traiter cet étage qu'une fois les étages supérieurs régulés, afin d'assurer que le nerf vague dorsal peut reprendre sa fonction harmonieuse de repos.

Synthèse : La Carte Polyvagale ROP

1. Étage Supérieur (Sécurité) :

C0-C1-C2, SSB/S2, Foramen Jugulaire, 4ème Ventricule.

Objectif : Relance vagale ventrale.

2. Étage Moyen (Régulation) :

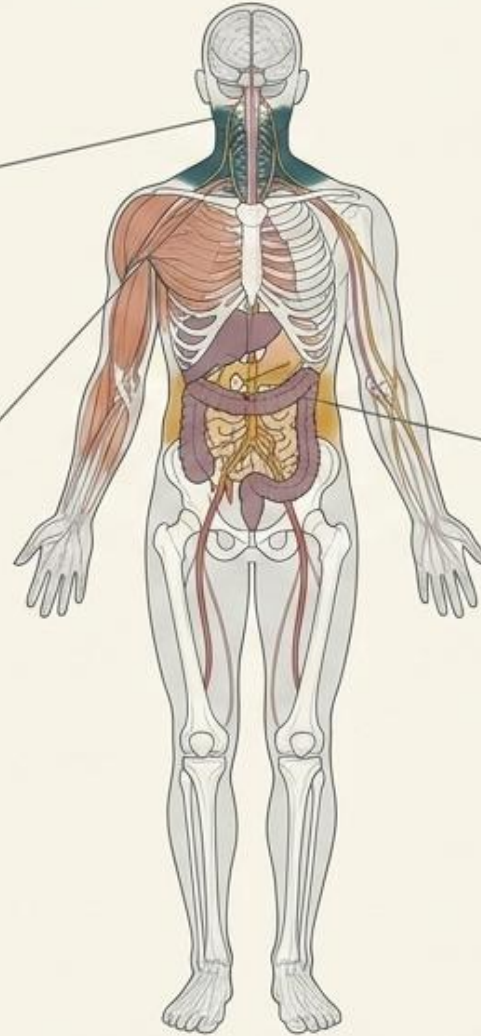
Axes SAM/HHS, Défilé thoracique.

Objectif : Diminution de l'hyper-sympathicotonie.

3. Étage Inférieur (Intégration) :

Plexus Coélique,
Plexus Hypogastrique.

Objectif : Restauration viscérale profonde.



L'objectif ultime de la ROP : restaurer la sécurité intérieure et renforcer la résilience neuro-végétative par l'intégration hiérarchique corporelle.

Le Principe Thérapeutique de la ROP



Organiser l'approche thérapeutique selon la hiérarchisation évolutive (de haut en bas).

L'Objectif

Restaurer le sentiment de sécurité intérieure et améliorer la Variabilité du Rythme Cardiaque (VRC).

La Méthode

Optimiser d'abord la branche ventrale du nerf vague (étage crânien) pour qu'elle puisse naturellement inhiber et réguler le système Sympathique (étage thoracique) et le nerf vague ancien (étage abdominal).

L'Anamnèse

L'interrogatoire clinique doit rechercher les dysfonctions associées à cette perte de hiérarchie neuro-végétative.